

TESTS D'ENDOCRINOLOGIE - Variante 5

*1. Dans la neurohypophyse sont stockés :

- a) TSH
- b) PRL
- c) GH
- d) ADH (AVP)
- e) ACTH

*2. Dans l'acromégalie, le patient présente :

- a) Voix infantile
- b) Téguments fins et délicats
- c) Prognathisme mandibulaire
- d) Exophtalmie infiltrante
- e) Rien de ce qui précède

*3. L'étiologie de la thyroïdite aiguë est :

- a) Auto-immune
- b) Post-irradiation
- c) Virale
- d) Toxique
- e) Bactérienne

*4. Le traitement du myxœdème se fait avec :

- a) ATS (Antithyroïdiens de synthèse)
- b) Thyroxine
- c) Corticothérapie
- d) Bêta-bloquants
- e) Diurétiques

*5. Lequel des aspects échographiques suivants suggère le caractère bénin d'un nodule thyroïdien ?

- a) Nodule hypoéchogène, hétérogène

- b) Contour irrégulier, festonné
- c) Microcalcifications
- d) Adénopathie régionale suspecte
- e) Aucun de ce qui précède

*6. Le diagnostic différentiel de l'hypoparathyroïdie se fait avec :

- a) L'épilepsie
- b) Les tumeurs cérébrales
- c) L'encéphalite saturnine
- d) La tétanie par alcalose métabolique ou respiratoire
- e) Tout ce qui précède

*7. L'examen d'imagerie de choix pour l'exploration de l'hypophyse est :

- a) Scanner cérébral (CT) sans produit de contraste
- b) Radiographie de la selle turcique
- c) Scintigraphie
- d) IRM centrée sur la zone hypophysaire avec produit de contraste (Gado)
- e) Aucune de ces réponses

*8. Les hormones minéralocorticoïdes sont sécrétées par :

- a) La zone fasciculée de la corticosurrénale (CSR)
- b) La médullosurrénale
- c) La zone glomérulée de la corticosurrénale (CSR)
- d) La zone réticulée de la corticosurrénale (CSR)
- e) L'appareil juxtaglomérulaire rénal

*9. L'ostéoporose dans l'hypercorticisme :

- a) Est une forme d'ostéoporose primaire
- b) Est considérée comme sévère si le T-score est entre -1 et -2,5
- c) Apparaît car l'excès de glucocorticoïdes stimule l'ostéorésorption et diminue l'ostéoformation et l'absorption intestinale du calcium
- d) Se traite de choix avec la calcitonine

- e) Pour un T-score < -3,5, on effectue uniquement un traitement prophylactique avec du Calcium et de la Vit D

*10. Le phéochromocytome :

- a) Est une tumeur de la corticosurrénale
- b) Lorsqu'il est associé au carcinome médullaire de la thyroïde et à l'hyperparathyroïdie primaire, il indique un syndrome MEN 2A
- c) Puisqu'il sécrète de l'ALDO (Aldostérone), il produit de l'HTA
- d) Le traitement de choix est la spironolactone
- e) Tout ce qui précède

11. Le syndrome de Sheehan (apoplexie hypophysaire) :

- a) Est une forme d'insuffisance hypophysaire partielle de l'adulte
- b) A pour cause la nécrose hypophysaire post-partum
- c) Les insuffisances des trophines hypophysaires apparaissent simultanément
- d) Les insuffisances des trophines hypophysaires apparaissent l'une après l'autre, selon une séquence caractéristique
- e) Le signe clinique initial est l'agalactie post-partum

12. Dans la liste ci-dessous, quelles trophines hypophysaires sont correctement attribuées aux glandes périphériques correspondantes ?

- a) TSH - Thyroïde
- b) PRL - Ovaire
- c) STH - Parathyroïde
- d) ACTH - Médullosurrénale
- e) ACTH - Corticosurrénale

13. Le syndrome endocrinien déterminé par un adénome hypophysaire sécrétant peut prendre l'aspect de :

- a) Hémianopsie bitemporale (signe de compression, non sécrétoire)
- b) Acromégalie
- c) HIC (Hypertension intracrânienne)
- d) Syndrome aménorrhée-galactorrhée

- e) Syndrome de Cushing

14. Le traitement médicamenteux de l'acromégalie :

- a) Est de première intention dans toutes les situations
- b) Peut se faire avec des analogues de la somatostatine
- c) Est indiqué pour les patients présentant une récurrence tumorale post-chirurgicale
- d) Les agonistes dopaminergiques sont de choix
- e) Chez les patients âgés, il est de première intention

15. Le tableau morphologique caractéristique de l'hypersomatotropisme comprend :

- a) Macroglossie et modifications dentaires (trêmes, diastèmes)
- b) Palais ogival
- c) Excès statural chez l'enfant (gigantisme)
- d) Mélanodermie
- e) Vergetures violacées

16. Dans le nanisme hypophysaire, le tableau clinique révèle :

- a) Augmentation du diamètre antéro-postérieur du crâne
- b) Acromicrie
- c) Voix grave
- d) Faciès infantile
- e) Faible tolérance à l'effort

17. Le syndrome aménorrhée-galactorrhée :

- a) Représente la manifestation clinique du prolactinome chez la femme
- b) Se traite avec la Bromocriptine
- c) Peut également apparaître comme effet secondaire d'un traitement par neuroleptiques
- d) Est le signe clinique inaugural du syndrome de Sheehan (c'est l'agalactie)
- e) En association avec l'hyperparathyroïdie primaire, indique un syndrome MEN 2A

18. Le traitement du nanisme hypophysaire :

- a) Se fait avec de l'insuline
- b) Se fait avec de la GH synthétique/semi-synthétique

- c) Se fait avec de l'IGF-1 dans le nanisme de Laron
- d) La substitution d'autres déficits en trophines hypophysaires n'est pas nécessaire
- e) Peut continuer avec l'administration de GH à l'âge adulte pour les bénéfices métaboliques

19. Dans le traitement du diabète insipide, on utilise :

- a) La desmopressine (adiurétine) dans les formes centrales
- b) La lévothyroxine
- c) L'astonin (fludrocortisone)
- d) Les diurétiques thiazidiques dans le DI néphrogénique
- e) Les diurétiques d'épargne potassique

20. Le tableau clinique du myxoœdème inclut :

- a) Tachycardie
- b) Faciès infiltré, œdémateux
- c) Tachypsychie
- d) Constipation
- e) Tendance à l'alopecie et dépilation du tiers externe des sourcils

21. La thyrotoxicose de type 2 induite par l'amiodarone :

- a) Apparaît chez les patients ayant des affections thyroïdiennes préexistantes
- b) Apparaît chez les patients ayant une thyroïde apparemment saine
- c) Présente une captation d'iode radioactif très faible
- d) Présente des anticorps antithyroïdiens positifs
- e) Bénéficie d'une corticothérapie

22. Les antithyroïdiens de synthèse (ATS) sont :

- a) Thiamazole, carbimazole, PTU
- b) Traitement de choix dans le myxoœdème
- c) Traitement de choix dans la maladie de Basedow
- d) Contre-indiqués en cas d'agranulocytose
- e) Contre-indiqués pendant la grossesse (le PTU est souvent utilisé au 1er trimestre)

23. Le traitement de la thyroïdite subaiguë de De Quervain consiste en :

- a) Thyroïdectomie d'urgence
- b) AINS (Anti-inflammatoires non stéroïdiens) dans les formes légères
- c) ATS
- d) Iode
- e) Corticothérapie dans les formes moyennes/sévères

24. Le traitement chirurgical des maladies thyroïdiennes est indiqué dans :

- a) Thyroïdite subaiguë
- b) Thyroïdite aiguë (seulement si abcès)
- c) Forme atrophique de la thyroïdite chronique auto-immune
- d) Maladie de Basedow (certaines formes)
- e) Goitre multinodulaire avec phénomènes de compression

25. La carence iodée :

- a) Apparaît pour un apport en iode inférieur à $50\ \mu\text{g/jour}$
- b) Apparaît pour un apport en iode entre $150\text{-}300\ \mu\text{g/jour}$
- c) Peut être évaluée par la valeur de l'iode urinaire (iodurie)
- d) Favorise l'apparition de maladies auto-immunes thyroïdiennes
- e) Produit le goitre endémique

26. Dans le cancer de la thyroïde :

- a) La calcitonine est le marqueur du carcinome médullaire
- b) Le dosage de la calcitonine sérique n'a pas de valeur préopératoire
- c) La thyroglobuline est le marqueur pour la récurrence du carcinome différencié
- d) Le dosage de la thyroglobuline sérique a une valeur préopératoire
- e) Le dosage de la calcitonine sérique a seulement une valeur postopératoire

27. Les signes cliniques majeurs de la maladie de Basedow sont :

- a) Goitre
- b) Perte de poids
- c) Thermophobie

- d) Tachycardie
- e) Téguments chauds et humides

28. À propos des méthodes d'exploration des nodules thyroïdiens, on peut affirmer que :

- a) L'échographie établit le diagnostic de certitude de la lésion
- b) La scintigraphie thyroïdienne établit le diagnostic de certitude
- c) La ponction thyroïdienne aspirative à l'aiguille fine est utile pour le diagnostic préopératoire
- d) Certains caractères sonographiques pourraient avoir une valeur prédictive de malignité
- e) L'exploration de la fonction thyroïdienne par dosages hormonaux n'est pas nécessaire dans tous les cas

29. Dans l'insuffisance parathyroïdienne, les signes de tétanie latente sont :

- a) Hypoplasie dentaire
- b) Cataracte sous-capsulaire
- c) Ongles fragiles
- d) Signe de Chvostek
- e) Signe de Trousseau

30. Le traitement de fond de l'hypoparathyroïdie consiste en l'administration de :

- a) Préparations de Calcium à la dose de 1-3g/jour
- b) PTH (généralement non utilisé en routine)
- c) Calcitonine
- d) Vitamine D sous forme active (Alpha-D3 ou Calcitriol)
- e) Bisphosphonates

31. Les investigations paracliniques utiles dans l'hyperparathyroïdie primaire sont :

- a) Échographie de la région cervicale
- b) Scintigraphie parathyroïdienne au Tc99 Sestamibi
- c) CT hypophysaire
- d) Ostéodensitométrie DEXA
- e) Caryotype

32. La sécrétion de PTH est régulée par :

- a) Concentration sanguine de Na
- b) Concentration sanguine de Ca
- c) Concentration sanguine de K
- d) Magnésium sérique
- e) Catécholamines

33. L'étiologie de l'hyperparathyroïdie secondaire inclut :

- a) Thérapie à l'iode 131
- b) Ostéomalacie
- c) Insuffisance rénale chronique
- d) Rachitisme
- e) Thyroïdectomie (cause l'hypoparathyroïdie)



34. Le traitement de l'hyperparathyroïdie se fait :

- a) Dans le but de corriger l'hypocalcémie et le déficit en calcitriol (concerne la forme secondaire)
- b) Par l'excision de l'adénome parathyroïdien (forme primaire)
- c) Avec des œstrogènes
- d) Avec des diurétiques de l'anse
- e) Dans les formes sévères, par parathyroïdectomie totale avec autotransplantation de tissu parathyroïdien dans l'avant-bras

35. Sur certaines hormones, l'excès de Glucocorticoïdes (GC) détermine :

- a) L'inhibition de la sécrétion de LH, FSH
- b) La stimulation de la sécrétion d'insuline
- c) L'inhibition de la sécrétion de glucagon
- d) L'inhibition de la sécrétion de GH
- e) La stimulation de la sécrétion de GH

36. Parmi les facteurs de risque de l'ostéoporose figurent :

- a) Sexe féminin
- b) Activité physique modérée
- c) Nulliparité

- d) Ménarche précoce

- e) Apport élevé en Ca

37. Les androgènes surrénaliens :

- a) Ont une action fortement virilisante

- b) Ont un rôle dans la définition des caractères sexuels secondaires à la puberté

- c) Produisent un catabolisme protéique

- d) Leur excès produit un syndrome de virilisation chez la femme

- e) Entrent en feedback négatif avec les gonadotrophines (FSH, LH)

38. Le traitement du syndrome adrénogénital congénital comprend :

- a) GC (Glucocorticoïdes) à but substitutif et suppressif de l'ACTH

- b) Immunosuppresseurs

- c) MC (Minéralocorticoïdes) dans les formes avec "perte de sel"

- d) Bisphosphonates

- e) Correction chirurgicale des intersexualités pendant l'enfance

39. Dans l'hyperaldostérionisme primaire, l'ionogramme sérique révèle :

- a) Na augmenté dans le sang (Hypernatrémie souvent discrète)

- b) Na augmenté dans l'urine

- c) K augmenté dans le sang (Il est bas : Hypokaliémie)

- d) Alcalose métabolique

- e) Aucune de ces réponses

40. Au test d'inhibition nocturne à la Dexaméthasone :

- a) Cortisol sérique $<1,8 \mu\text{g/dl}$ exclut le syndrome de Cushing

- b) Cortisol sérique $>10 \mu\text{g/dl}$ exclut le syndrome de Cushing

- c) Cortisol sérique $>10 \mu\text{g/dl}$ plaide pour le syndrome de Cushing

- d) L'ACTH sérique augmente en conditions normales

- e) L'ALDO sérique diminue

41. Le tableau clinique du syndrome de Cushing inclut :

- a) Hypotension artérielle

- b) HTA (Hypertension artérielle)
- c) Ecchymoses
- d) Atrophies musculaires
- e) Pâleur faciale (le visage est érythrosique/rouge)

42. Dans le syndrome adrénogénital par déficit total en 21-hydroxylase :

- a) La symptomatologie apparaît tardivement
- b) La symptomatologie apparaît immédiatement après la naissance
- c) Le syndrome de virilisation est sévère
- d) Apparaît une alcalose métabolique
- e) Apparaît une insuffisance corticosurrénale aiguë

43. Dans l'ostéoporose, les investigations suivantes sont utiles :

- a) FAL (Phosphatase alcaline)
- b) Glycémie
- c) Calcium sérique et 25-OH-vitamine D
- d) PTH
- e) Na et K sériques

44. L'examen de laboratoire dans l'insuffisance corticosurrénale chronique primaire révèle :

- a) ALDO sérique augmenté
- b) ACTH sérique augmenté
- c) Cortisol sérique bas
- d) Hypokaliémie (On trouve une Hyperkaliémie)
- e) Hypernatrémie (On trouve une Hyponatrémie)

45. Dans l'insuffisance CSR chronique primaire (maladie d'ADDISON), le tableau clinique inclut :

- a) Mélanodermie
- b) Hypertonie musculaire (c'est une hypotonie/fatigue)
- c) HTA (c'est une hypotension)
- d) Douleurs abdominales

- e) Œdèmes

46. Le traitement de l'insuffisance CSR aiguë nécessite :

- a) Traitement per os
- b) Traitement d'urgence par perfusion
- c) HHC (Hémisuccinate d'Hydrocortisone) en bolus i.v.
- d) Vitamine D
- e) Insuline

47. La prévention des complications de la corticothérapie nécessite :

- a) Antiacides
- b) Restriction protéique
- c) Préparations de Calcium et Vitamine D
- d) Utilisation de GC à durée d'action longue
- e) Régime hyposodé

48. L'ostéoporose secondaire endocrine apparaît dans :

- a) Acromégalie
- b) Hypogonadisme
- c) Hyperparathyroïdie primaire
- d) Hyperaldostéronisme (HyperALDO)

49. Les complications des bisphosphonates sont :

- a) Infections dentaires (Ostéonécrose de la mâchoire)
- b) Anomalies de l'œsophage (Oesophagite)
- c) HTA
- d) Diabète sucré (DZ)
- e) Hypogonadism

50. La médication contraceptive est contre-indiquée en cas de :

- a) Hypotension artérielle
- b) Grossesse et allaitement
- c) Syndrome de Turner

- d) Maladie thromboembolique
- e) Cirrhose hépatique